

DGSN - SERVICE DE SANTE - PROTOCOLE DE CONTROLE MEDICAL

Nom du Fonctionnaire :

Date de l'examen : / / 2026

Grade / Unite :

Age : ans

PARTIE I : SIGNES CLINIQUES OBJECTIFS (Pathologie Reelle)

- ☐ Amyotrophie (Difference de perimetre > 1,5 cm entre les deux membres)
- ☐ Abolition ou diminution d'un reflexe osteo-tendineux (ROT L4 ou S1)
- ☐ Deficit moteur vrai (Testing segm. contre resistance ou marche impossible)
- ☐ Lasegue radiculaire franc (Douleur trajet electrique entre 30 et 70 deg)
- ☐ Concordance exacte imagerie/clinique (Hernie avec conflit prouve)
- ☐ Signes inflammatoires ou raideur segmentaire non-volontaire

PARTIE II : SIGNES DE WADDELL (Simulation / Majoration)

- ☐ Hyper-reactivite / Grimaces / Cris lors de manoeuvres indolores
- ☐ Pression Axiale : Douleur lombaire lors de l'appui sur le crane
- ☐ Rotation Simulee : Douleur lombaire lors du pivotement du bloc tronc
- ☐ Flip Test (Distraction) : Lasegue positif allonge mais negatif assis
- ☐ Troubles sensitivo-moteurs non-anatomiques (global/changeant)

PARTIE III : TEST DE HOOVER

- ☐ Test de Hoover POSITIF (Absence d'appui controlateral = Simulation)

PARTIE IV : CONSTAT ET DECISION DU MEDECIN CONTROLEUR

SCORE OBJECTIF : / 6 | SCORE WADDELL : / 5

A. CAS DE PATHOLOGIE REELLE :

- ☐ Etat de sante altere : Concordance anatomo-clinique.
- ☐ Arret de travail JUSTIFIE. Duree recommandee : jours.

B. CAS DE SIMULATION OU MAJORATION :

- ☐ Incoherence anatomo-clinique (Waddell ≥ 3).
- ☐ Majoration manifeste des symptomes / Absence de lesion handicapante.
- ☐ Arret de travail NON JUSTIFIE. Reprise immediate du service.

GUIDE TECHNIQUE DES TESTS DE NON-ORGANICITE (Recto)

1. Pression Axiale

Exercez une pression verticale sur le vertex du patient debout. Anatomiquement, cela n'induit aucune contrainte discale lombaire. Une plainte de douleur lombaire signe une majoration.

2. Rotation Simulee

Faites tourner le bassin et les épaules en bloc. Le rachis ne subit aucune torsion. Si le patient dit avoir mal au dos, c'est une réponse simulée.

3. Flip Test (Lasegue Distrait)

Faites mine d'examiner les pieds du patient assis et tendez la jambe à 90 degrés. S'il n'a pas mal alors que son Lasegue allongé est positif à 20 degrés, la simulation est prouvée.

4. Signe de Hoover

L'expert place ses mains sous les deux talons. Le patient doit lever la jambe 'malade'. Si le talon de la jambe saine ne s'enfonce pas dans votre main, le patient ne fait aucun effort réel.

5. Testing Moteur L5/S1

L5 : Releve du gros orteil. S1 : Marche sur la pointe des pieds. Une hernie 'irritative' ne peut pas causer une paralysie totale de ces mouvements.

Cachet du Medecin Controleur :

Signature :